

БЛОК 13: Реабилитация голеностопа (CAI) и паховые боли (Doha Agreement)

Консенсусы *International Ankle Consortium*, протокол *Copenhagen Adduction u* фасциальная интеграция

Ключевые источники: Phillip A. Gribble et al. (BJSM, 2016); Eamonn Delahunt et al. (2018); Adam Weir et al. (Doha Agreement on Groin Pain, BJSM, 2015); Joar Harøy et al. (BJSM, 2019).

1. Хроническая нестабильность голеностопа (Chronic Ankle Instability — CAI)

Растяжение передней таранно-малоберцовой связки (ATFL) и пяточно-малоберцовой связки (CFL) — самая частая травма в баскетболе. У 40% атлетов после первого подворота развивается синдром CAI из-за утраты механической поддержки и проприоцептивного дефицита механорецепторов.

Современный протокол ведения острой травмы (PEACE & LOVE вместо устаревшего RICE):

- PEACE (Первые 72 часа): Protection (защита брейсом), Elevation (возвышенное положение), Avoid Anti-inflammatory (отказ от НПВП и агрессивного льда, блокирующего фазу регенерации макрофагов), Compression (компрессия), Education (обучение атлета).
- LOVE (Последующие дни): Load (оптимальная механическая нагрузка), Optimism (психологический настрой), Vascularisation (кардио-активность без боли для стимуляции кровотока), Exercise (ранние упражнения на мобильность и баланс).

2. Сенсомоторная прогрессия реабилитации голеностопа

1. Восстановление дорсифлексии: мобилизация сустава с лентой (Mulligan A-P Glide) до восстановления симметрии теста «колени к стене» (разница между ногами < 1.5 см).
2. Сила малоберцовых мышц (m. peroneus longus et brevis): концентрические и эксцентрические отведения стопы наружу с резиной для создания динамического замка от повторной инверсии.
3. Проприоцепция: стойка на одной ноге на жестком полу → балансировочная подушка AIREX → стойка с закрытыми глазами → ловля баскетбольного мяча на нестабильной платформе.

3. Паховые боли: Дохийский консенсус (Doha Agreement, Weir et al., 2015)

Консенсус устранил устаревшие расплывчатые термины «паховая грыжа спортсмена» и «пубалгия», разделив паховую боль на 4 клинические категории:

- Adductor-related (Связанная с приводящими): Боль при пальпации сухожилий длинной приводящей мышцы и при тесте на сжатие коленей (Squeeze test).
- Iliopsoas-related (Связанная с подвздошно-поясничной): Боль при изолированном сгибании бедра против сопротивления.
- Inguinal-related (Связанная с паховым каналом): Боль в проекции пахового канала без пальпируемой грыжи, усиливающаяся при натуживании.
- Pubic-related (Связанная с лобковым симфизом): Боль при пальпации лобкового сочленения.

4. Протокол укрепления приводящих Copenhagen Adduction Exercise (Harøy et al., 2019)

Кластерное рандомизированное исследование доказало снижение риска травм паха у спортсменов на 41% при внедрении протокола Copenhagen:

Уровень сложности	Положение опоры партнера	Объем (подходы × повт.)
Уровень 1 (Базовый)	Партнер удерживает согнутую ногу под колено	2–3 подхода × 8–10 повторений на сторону
Уровень 2 (Средний)	Партнер удерживает прямую ногу за середину голени	3 подхода × 10–12 повторений на сторону
Уровень 3 (Продвинутый)	Партнер удерживает ногу за лодыжку (максимальный рычаг)	3 подхода × 12–15 повторений на сторону